

# Περίπτωση 25η

Άνδρας 29 ετών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 μεταφέρεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με συμπτώματα σοβαρής αφυδάτωσης λόγω εμέτων και πολυουρίας.

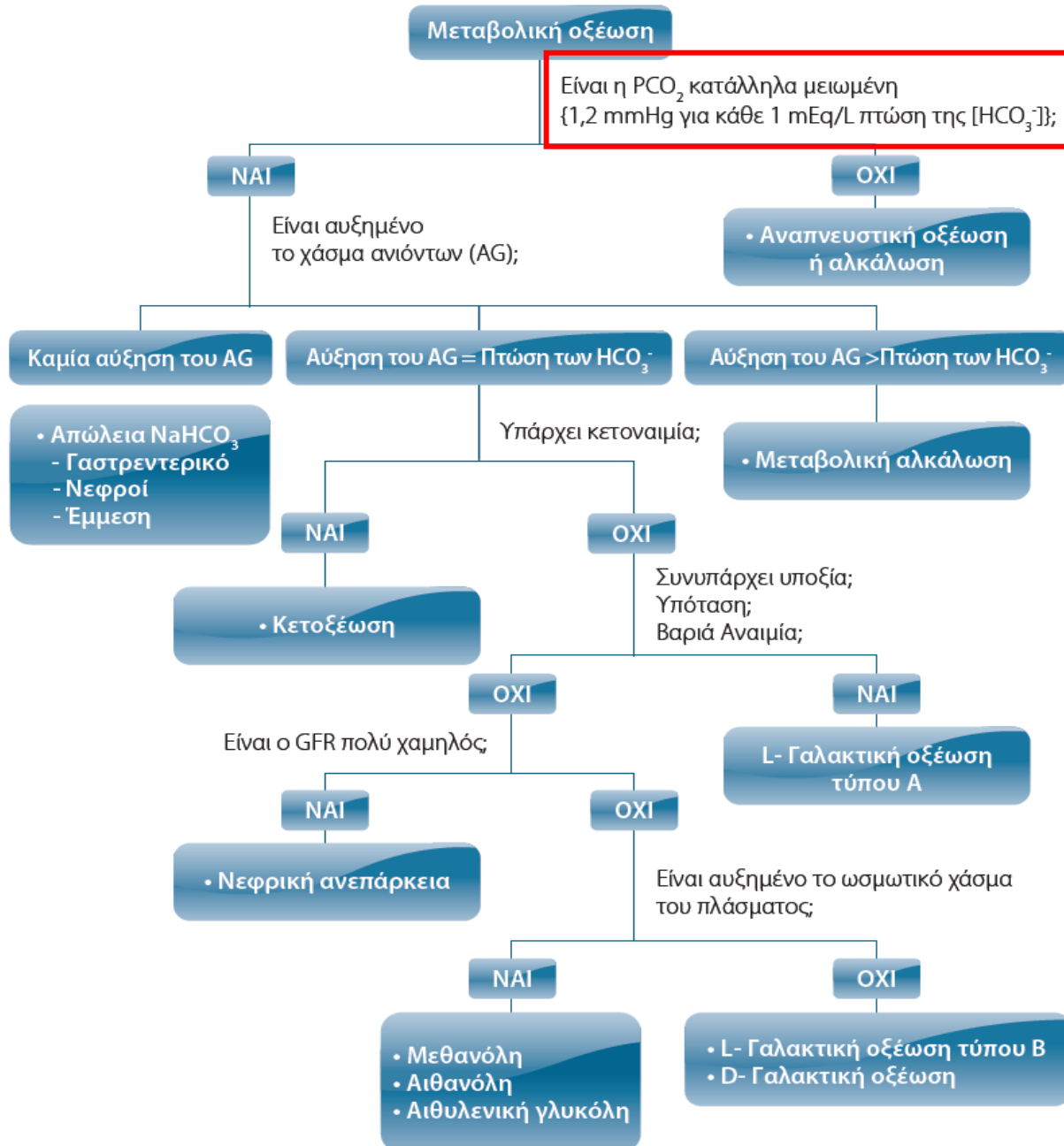
- (FiO<sub>2</sub> 21%)
- PO<sub>2</sub> = 76 mmHg
- PCO<sub>2</sub> = 28 mmHg
- pH = 7.32
- [HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>] = 14 mEq/L
- [Na<sup>+</sup>]<sub>ούρων</sub> = 11 mEq/L
- [K<sup>+</sup>]<sub>ούρων</sub> = 21 mEq/L
- [Cl<sup>-</sup>]<sub>ούρων</sub> = 08 mEq/L
- [Na<sup>+</sup>] = 142 mEq/L
- [K<sup>+</sup>] = 5.5 mEq/L
- [Cl<sup>-</sup>] = 100 mEq/L
- [Γλυκόζης] = 500 mg/dl
- [Ουρίας] = 37 mg/dl
- [Κρεατινίνης] = 1.0 mg/dl

# Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Μεταβολική οξέωση + μεταβολική αλκάλωση
- β. Αναπνευστική αλκάλωση + μεταβολική οξέωση
- γ. Μεταβολική αλκάλωση
- δ. Μεταβολική οξέωση

- pH = 7.32 (< 7.40)
- $[\text{HCO}_3^-] = 14 \text{ mEq/L}$  (< 24 mEq/L)
- **Μεταβολική οξέωση (κύρια διαταραχή)**

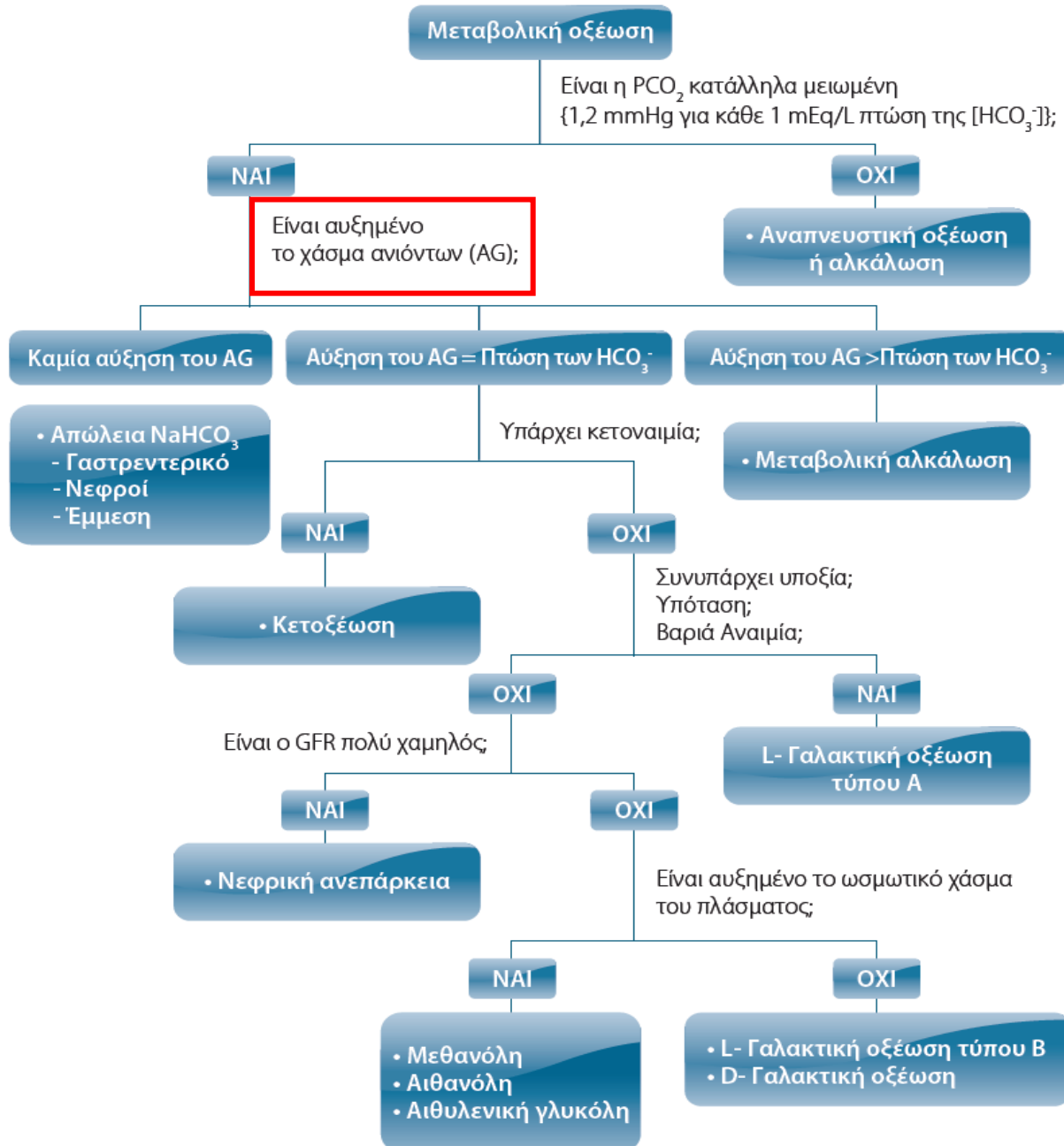
## ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Είναι κατάλληλα ↓ η  $\text{PCO}_2$ ;

- $[\text{HCO}_3^-] = 14 \text{ mEq/L}$ , ↓ κατά  $10 \text{ mEq/L}$
- $\text{PCO}_2 = 28 \text{ mmHg}$ , αντιστοίχως ↓ κατά  $(10 \times 1.2 = 12)$   $12 \text{ mmHg}$
- Η  $\text{PCO}_2$  ↓ κατά  $1.2 \text{ mmHg}$  για κάθε  $1 \text{ mEq/L}$  ↓ της  $[\text{HCO}_3^-]$

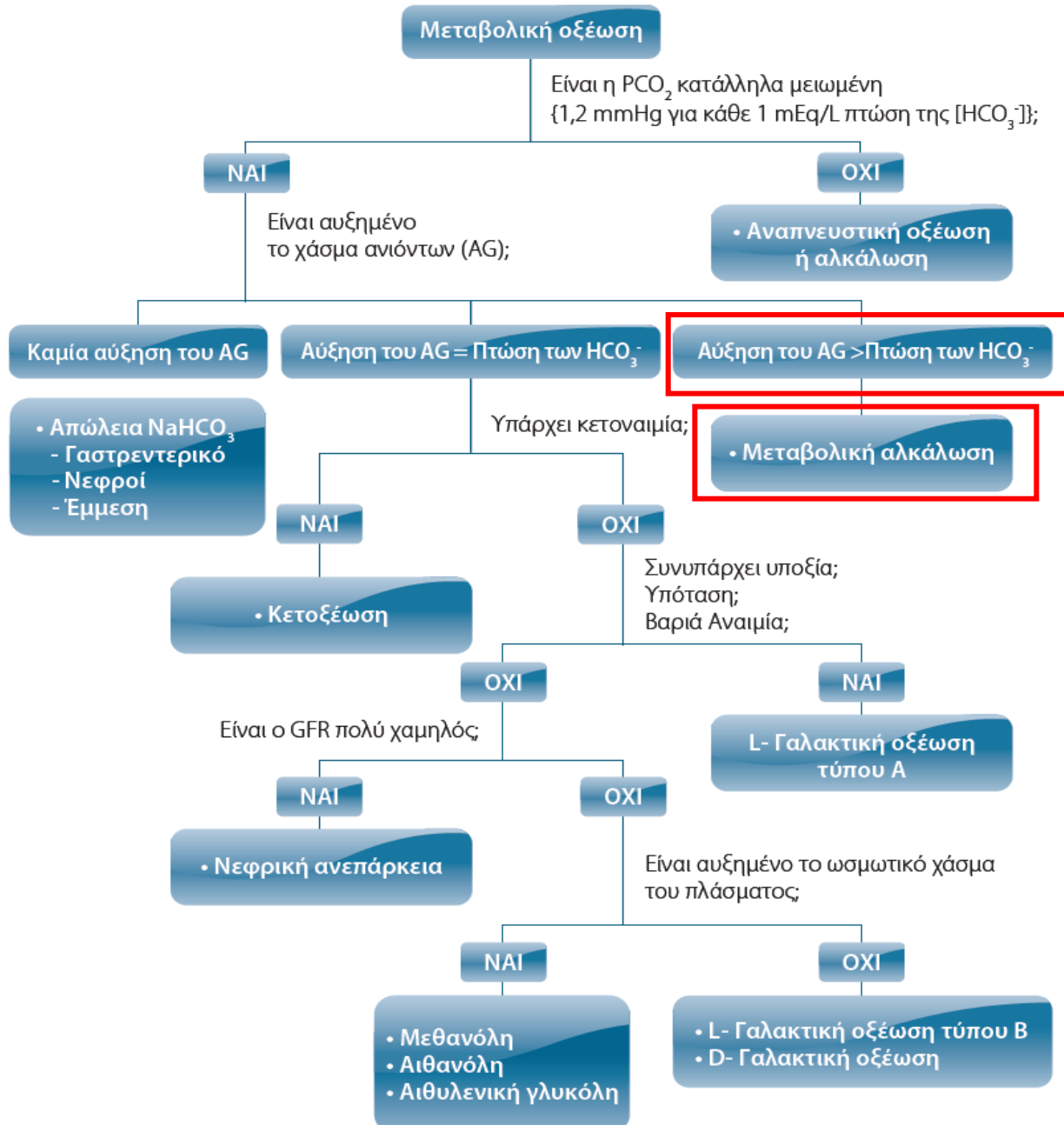
## ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Είναι ↑ το χάσμα ανιόντων (Anion Gap);

- $AG = [Na^+] - \{[Cl^-] + [HCO_3^-]\} = 142 - (100+14) = 28 \text{ mEq/L}$
- AG ↑ κατά 16 mEq/L
- $[HCO_3^-] = 14 \text{ mEq/L}$ , ↓ κατά 10 mEq/L
- Η αύξηση του AG είναι μεγαλύτερη από την πτώση των  $[HCO_3^-] \Rightarrow$  Συνυπάρχει μεταβολική αλκάλωση

## ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



- $[\text{Γλυκόζη}] = 500 \text{ mg/dl} \Rightarrow \text{Μεταβολική οξέωση}$   
(διαβητική κετοξέωση)
- Αφυδάτωση  $\Rightarrow$  Μεταβολική αλκάλωση με  $\downarrow$  μειωμένο  
εξωκυττάριο όγκο
- $[\text{Na}^+]_{\text{ούρων}} = 11 \text{ mEq/L}$  και  $[\text{Cl}^-]_{\text{ούρων}} = 08 \text{ mEq/L} \Rightarrow$  η  $\downarrow$  του  
εξωκυτταρίου όγκου οφείλεται στην απώλεια γαστρικών  
υγρών (λόγω εμέτων) και στην πολυουρία

- Συμπερασματικά, ο ασθενής εμφανίζει μεταβολική οξέωση με αυξημένο AG λόγω διαβητικής κετοξέωσης και μεταβολική αλκάλωση λόγω μειωμένου εξωκυττάριου όγκου (με μειωμένη  $[Cl^-]_{\text{ούρων}}$ ) συνεπεία επανειλημμένων επεισοδίων εμέτων

# Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Μεταβολική οξέωση + μεταβολική αλκάλωση
- β. Αναπνευστική αλκάλωση + μεταβολική οξέωση
- γ. Μεταβολική αλκάλωση
- δ. Μεταβολική οξέωση